

TEMA 1.4 • PEDIATRÍA

Patología Neonatal General

PERFIL EUNACOM 2.01.1.120

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Patología Neonatal General

1. Hipoglicemia Neonatal

Factores de riesgo: GEG, PEG, hijo de madre diabética (HMD), pretérmino, postérmino, poliglobulia.

- **Clínica:** Se manifiesta entre las **2–4 horas** de vida (momento de mayor riesgo).
- Temblor, irritabilidad, llanto (síntomas simpáticos — aparecen primero)
- Letargia, sopor, convulsiones, hipotonía (neuroglucopenia — más graves)

Diagnóstico: Hemoglucotest < **45 mg/dL** (confirmar con glicemia venosa).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El corte en RN es < 45 mg/dL, muy diferente al adulto (< 60 mg/dL). No confundir.

Tratamiento:

TABLA 1.4.1: SEVERIDAD VS CRITERIOS

SEVERIDAD	CRITERIOS	TRATAMIENTO
Leve	> 30 mg/dL + asintomático	Suero glucosado oral
Severa	< 30 mg/dL o sintomático	Suero glucosado endovenoso

Screening: Hemoglucotest a las **2 horas** de vida en todo RN con factores de riesgo.

2. Hipocalcemia Neonatal

Factores de riesgo: HMD, pretérmino, asfixia neonatal.

- **Clínica (afecta cerebro, músculo y corazón):**
- Irritabilidad, hipotonía, convulsiones
- Tetania, espasmos musculares
- **Alargamiento del QTc** en ECG → riesgo de **torsade de pointes**
- **Diagnóstico:**
- Calcio total < **7 mg/dL** (adulto: < 8.5 mg/dL)
- Calcio iónico < **3.5 mg/dL** (más fidedigno)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El RN tolera calcio más bajo que el adulto. El corte es **7 mg/dL** (no 8.5).

Tratamiento:

TABLA 1.4.2: SEVERIDAD VS CRITERIOS

SEVERIDAD	CRITERIOS	TRATAMIENTO
Leve	Delta < 1 mg/dL + asintomático	Observar + control de calcemia
Severa	Delta > 1 mg/dL o sintomático	Gluconato de calcio EV en goteo

3. Poliglobulia / Policitemia Neonatal

Factores de riesgo: GEG, PEG, postérmino, HMD, preeclampsia, RCIU.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El **premature** NO produce poliglobulia → produce **anemia**. Es el único que no tiene este riesgo.

Causa adicional: Corte tardío del cordón (> 1 min) → poliglobulia. Corte muy precoz → anemia. La recomendación actual es esperar **1 minuto**

antes de pinzar.

- **Clínica:**
- Piel **pletórica** (roja-violácea, "llena de sangre")
- Convulsiones neonatales
- Hipoglicemia asociada (los GR consumen glucosa)

Diagnóstico: Hematocrito > **65%** (adulto: > 55%).

Tratamiento:

TABLA 1.4.3: HEMATOCRITO VS CLÍNICA

HEMATOCRITO	CLÍNICA	CONDUCTA
66–69%	Asintomático	Observar
≥ 70% o sintomático	Cualquiera	Eritroféresis (sueroclis): extracción de sangre + infusión de suero para diluir

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El corte para eritroféresis es **hematocrito ≥ 70% o síntomas**. Este dato se ha preguntado.

4. Encefalopatía Hipóxico-Isquémica (EHI)

Causa: Asfixia neonatal / hipoxia intrauterina (insuficiencia placentaria, preeclampsia, sufrimiento fetal).

- **Clínica:**
- Letargia, hipotonía, convulsiones
- Antecedente de asfixia perinatal, líquido meconial, APGAR bajo
- **Diagnóstico:**
- Descartar otras causas de encefalopatía neonatal: hipoglicemia, hipocalcemia, poliglobulia
- **Ecografía cerebral transfontanelar** (la fontanela anterior abierta es ventana ecográfica)
- - Busca hemorragia periventricular, lesiones isquémicas

Tratamiento: Soporte. Rehabilitación si hay secuela neurológica.

Convulsiones neonatales: Tratamiento con **fenobarbital** + tratar la causa de base.

5. Sepsis Neonatal

Agente más frecuente: **Streptococcus agalactiae (Streptococcus grupo B / beta-hemolítico grupo B)**. Segundo lugar: *E. coli* y gram negativos del canal del parto.

- **Factor de riesgo más importante:** **Prematuridad** (< 37 semanas).
- Profilaxis antibiótica intraparto a todo RN prematuro
- RN prematuro + RPM → riesgo de sepsis ~30%

Otros factores: RPM, infección ovular/corioamnionitis, fiebre materna intraparto.

- **Clínica:**
- **Fiebre ≥ 38°C** en RN (hasta 37.9°C es normal) → sepsis hasta demostrar lo contrario
- Hipotermia / alteraciones de termorregulación en RN inicialmente sano
- Letargia, succión débil, rechazo alimentario
- Hipotonía, convulsiones (meningitis concomitante)
- Ictericia, hepatoesplenomegalia
- **RN que "se echa a perder" en los días siguientes al nacimiento → sepsis hasta demostrar lo contrario**

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La hepatoesplenomegalia en un RN que nació BIEN y luego se deteriora → **sepsis**. Si nació con hepatoesplenomegalia + microcefalia + malformaciones → **TORCH**.

- **Estudio:** No esperar resultados para iniciar antibióticos.
- Hemograma + PCR (parámetros inflamatorios)
- Pruebas de función renal, hepática
- **Hemocultivos**
- Sedimento de orina + urocultivo
- Radiografía de tórax
- **Punción lumbar** (siempre en sospecha de sepsis neonatal)
- **Tratamiento empírico:**
- **Ampicilina** (cubre Streptococcus grupo B)
- **Cefotaxima** o **Gentamicina** (cubre E. coli y gram negativos)
- Esquema: **Ampi + Cefota** o **Ampi + Genta**
- + Soporte general (termorregulación, hidratación, etc.)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"RN de 39 semanas, madre con diabetes gestacional mal controlada, peso al nacer 4.200 g. A las 2 horas de vida presenta temblores finos y succión débil. Glucosa capilar: 35 mg/dL. ¿Cuál es la conducta inmediata?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Patología Neonatal General. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Hipoglicemia neonatal: glucosa <45 mg/dL; factores de riesgo: macrosómico, prematuro, madre diabética
- Hipocalcemia precoz (días 1-3): Ca total <7 mg/dL o Ca iónico <1.1; en prematuros y asfícticos
- Poliglobulia neonatal: Hto venoso >65%; hiperviscosidad; tratamiento eritroféresis parcial
- EHI (encefalopatía hipóxico-isquémica): clasificación Sarnat I/II/III; hipotermia en moderada-severa
- Sepsis neonatal precoz (<72h): Streptococcus grupo B; tratamiento: ampicilina + cefotaxima
- Sepsis tardía (>72h): S. aureus y estafilococos coagulasa negativo; vancomicina + aminoglucósido

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PATOLOGÍA NEONATAL GENERAL)**PREGUNTA 1**

RN de 39 semanas, madre con diabetes gestacional mal controlada, peso al nacer 4.200 g. A las 2 horas de vida presenta temblores finos y succión débil. Glucosa capilar: 35 mg/dL. ¿Cuál es la conducta inmediata?

- ☐ A) Administrar glucagón intramuscular
- ☐ B) Alimentación oral o por SNG con fórmula
- ☐ C) Bolo de suero glucosado 10% 2 mL/kg IV + infusión continua de glucosa
- ☐ D) Repetir glucosa capilar en 30 minutos sin tratamiento
- ☐ E) Administrar corticoides para estimular gluconeogénesis

PREGUNTA 2

RN de 33 semanas presenta apneas repetidas, hipotonía marcada y convulsiones a las 12 horas de vida. Antecedente de sufrimiento fetal agudo en el parto. ¿Cuál clasificación y manejo corresponde?

- ☐ A) EHI grado I (leve) – observación ambulatoria
- ☐ B) EHI grado II (moderada) – hipotermia terapéutica sistémica
- ☐ C) EHI grado III (severa) – solo cuidados paliativos
- ☐ D) Sepsis neonatal – antibióticos empíricos
- ☐ E) Meningitis neonatal – punción lumbar y antibióticos

PREGUNTA 3

RN de 38 semanas presenta a las 18 horas de vida fiebre 38.5°C, rechazo alimentario e irritabilidad. Madre tuvo fiebre intraparto y colonización positiva por Streptococcus agalactiae en cultivo vaginal. ¿Qué tratamiento iniciar?

- ☐ A) Vancomicina + gentamicina
- ☐ B) Cefazolina en monoterapia
- ☐ C) Ampicilina + cefotaxima (o gentamicina)
- ☐ D) Penicilina G en monoterapia
- ☐ E) Observación y repetir hemograma en 6 horas

RESUMEN: PATOLOGÍA NEONATAL GENERAL

⚠ El prematuro NO produce poliglobulia → produce anemia. Es el único que no tiene este riesgo. ⚠ Causa adicional: Corte tardío del cordón (> 1 min) → poliglobulia. Corte muy precoz → anemia. La recomendación actual es esperar 1 minuto antes de pinzar. Causa: Asfixia neonatal / hipoxia intrauterina (insuficiencia placentaria, preeclampsia, sufrimiento fetal).